Anamnesefragen

Was kann ich für Sie tun?
Was führt Sie zu uns?

Wo genau haben Sie diese Schmerzen?
Seit wann haben Sie diese Schmerzen?
Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
Haben Sie Brustschmerzen, Luftnot oder ein Engegefühl?
Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, z. B. Belastung oder nach dem Essen?
Haben Sie sich am Brustkorp verletz?
Was haben Sie gegessen?
Wo haben Sie das gegessen?
Gibt es jemanden, der das gleiche Essen gegessen hat und ähnliche Symptome hat?
Hat Ihre Frau auch ahnliche Beschwerde?
Sind die Schmerzen dauerhaft da, oder gehen sie wieder weg?
Wie lange dauert die Attacke?
Ist es das erste Mal, oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome?
Waren Sie deswegen schon einmal bei Ihrem Hausarzt?
Wurde Ihnen Untersuchung durchgeführt?
Sind die Schmerzen mit der Zeit schlimmer geworden?
Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen stechend oder dumpf?
Wie stark sind die Schmerzen?
Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt, z. B. Bewegung, oder etwas, das sie lindert, z. B. Hinlegen?
Wie viele Kissen benutzen Sie nachts?
Haben Sie etwas gegen die Schmerzen genommen?

Leiden Sie unter Sodbrennen, saures Ausstoßen?

Haben Sie Schluckprobleme?

Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Heiserkeit, Glabusgefühl im Hals haben?

Haben Sie Husten?

Wann trriit der Husten auf?

Ist der Husten dauerhaft da oder geht er wieder weg?

Ist der Husten trocken oder mit Auswurf?

Was essen Sie normalerweise? Essen Sie gerne Fleisch, Wurst, Sahne, Käse oder fetthaltige Speisen?

Trinken Sie Kaffe? Wie wiel Kaffe trinken Sie?

Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen?
Seit wann?
Wie oft?
Wie sah das Erbrochene aus? Welche Farbe und Konsistenz hatte es?
Gab es Blut im Erbrochenen?

Wie ist Ihr Appetit?
Haben Sie in der lezten Zeit Gewicht abgenommen?

Haben Sie Fieber?
Seit wann?
Haben Sie die Temperatur gemessen?
Wie hoch war sie?
Wo haben Sie gemessen?
Haben Sie Schüttelfrost?
Schwitzen Sie mehr als sonst oder haben Sie Schweißausbrüche bzw. Nachtschweiß?

Haben Sie Probleme beim Stuhlgang?
Seit wann?
Wie oft?
Welche Farbe und Konsistenz hat der Stuhl?
Gibt es Blut im Stuhl?

Haben Sie Probleme beim Wasserlassen?
Haben Sie Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen?
Welche Farbe hat der Urin?
Gibt es Blut im Urin?

Haben Sie Völlegefühl oder Blähungen?

Haben Sie verstärkten Durst bemerkt?
Wie viel Wasser trinken Sie täglich?

Gibt es andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten?

Am Ende des Gesprachs Aufklarung

Ich habe den Verdacht auf Refluxkrankheit. Das bedeutet, dass die Säure aus Ihrem Magen in Ihre Speiseröhre aufsteigt. Das ist nicht schlimm und kann einfach mit Säureblockern behandelt werden. Aber das bleibt nur eine Vermutung deswegen sollen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Ich werde zuerst körperliche Untersuchung machen, dann Blut für das Labor abnehmen und einen EKG schreiben um eine Herzursache auszuschließen. Danach werde ich eine Magenspiegelung durchführen. Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich mit meinem Oberarzt, dann komme ich zu Ihnen, erzähle Ihnen alles

Wissen Sie, was das ist?Haben Sie an mich noch Fragen?

EKG:
Ein EKG ist eine schmerzfreie und Strahlenfreie Untersuchung. Es dauert nur 5 Minuten und wir legen Elektroden auf Ihre Brust und Ihre Gliedmaßen, um den Rhythmus Ihres Herzens zu registrieren. Sie müssen nur ruhig liegen bleiben.

Magenspiegelung / ÖGD:
Die Magenspiegelung ist eine Untersuchung, mit der wir die hohlen Organe in Ihrem Körper beobachten können. Dazu führen wir einen Schlauch mit einer Kamera durch den Mund ein. Wir geben Ihnen ein Beruhigungsmittel, damit Sie nichts spüren. Wir können auch einige Gewebeproben (Biopsien) entnehmen, damit können wir eine Diagnose stellen.

ARZT-ARZT GESPRACH

Reaktionen:

Ich habe viel gewartet. GERD

Ja, das tut mir sehr Leid, aber Sie sind in der Notaufnahme und leider hatten wir einen akuten Notfall und dieser mustte zuerst behandelt werden, aber jetzt können wir starten.

- Entschuldigen Sie die lange Wartezeit, wir haben heute viele Patienten, deshalb war ich beschäftigt, aber ich bin jetzt bereit, mich um Sie zu kümmern. Können wir anfangen?
- Deshalb war ich beschäftigt, aber ich bin jetzt da für Sie. Können wir anfangen?

Beschäftigt sein: meşgul olmak

Warum fragen Sie nach meinem Gewicht und meiner Größe? GERD

1. Ich stelle diese Fragen, um die Medikamentendosis zu berechnen.
2. Ich frage nach Ihrem Gewicht und Ihrer Größe, um die Medikamentendosis zu berechnen und einige Risikofaktoren zu **berücksichtigen.**

Mein Hausarzt ist im Urlaub. Deswegen bin ich hier gekommen. GERD – UAW von Chemo

1. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Machen Sie sich keine Sorgen, ich kümmere mich um Sie.
2. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Wir werden unser Bestes tun.

Könnten die Beschwerden eine Nebenwirkung meiner Medikamente sein? GERD

Nein, sie sind keine typischen Medikamente, die den Magen schaden.

Habe ich Krebs? GERD

Ich verstehe Ihre Sorge. Davon geht es erstmal nicht aus. Versuchen Sie bitte positiv zu denken. Es gibt weitere unschädliche Gründe/Erkrankungen, die zu Ihren Beschwerden passen.

Ihre Beschwerden könnten viele weitere Gründe haben.

Können Sie im Labor verstehen, ob ich Krebs habe? GERD

Die Laboruntersuchungen können keine direkte Aussage treffen, ob ein Krebs vorliegt. Dafür wird immer weitere Untersuchungen benötigt, wie z.B. Magenspieglung

Machen Sie selbst die Magenspiegelung? GERD

Nein, die Magenspiegelung wird von einem Oberarzt durchgeführt. Ich werde auch dort sein, wir arbeiten als Team.

Als ich jung war, war die Untersuchung nicht gut, die Ärzte haben mir gesagt, dass ich einen Sohn habe, aber dann hatte ich eine Tochter. GERD

Ja, aber Heutzutage haben wir bessere Untersuchungsarten, machen Sie keine Sorgen.

GERD

- **Patient/ Patientin Datum (Vorname, Name, Geb.-Datum)**

Name: Jürgen Kottwez
Alter: 46 J. (geb. am 22.6.1976)
Größe: 1,91 m
Gewicht: 91 kg

- **Aufnahmegrund/ Diagnose (stichwortartig)**

Hauptbeschwerde:

- gestern Abend plötzlich aufgetretene, anhaltende, brennende und retrosternale Schmerzen mit Ausstrahlung in den Hals.
- Die Schmerzintensität: 6/10 auf der NRS
- Auslöser: Verzehr von Pizza und Kaffee
- Lindernde Faktoren: Oberkörperhochlagerung beim Liegen, Einnahme von Maaloxan und Gaviscon (symptomatische Linderung)
- Verstärkende Faktoren: Hinlegen, Essen
- Ähnliche, aber leichtere postprandiale Schmerzen seit etwa 3 Wochen.
- Begleitsymptome:
  - Nausea ohne Emesis
  - Sodbrennen
  - Engegefühl im Thorax
  - saurer Geschmack im Mund

V/A:

schmerzbedingte Insomnie

V/E:

aHT seit 5 Jahren (kontrolliert, letzte Messung vor 2 Tagen: 120/80 mmHg)
Hypercholesterinämie seit 1,5 Jahren

M:

Candersartan 12 mg, 1-0-0 p.o.
Simvastatin 40 mg, 1-0-0 p.o.
Maaloxan, bei Bedarf
Gaviscon, 1-0-0 p.o.

Vor-op:

Appendektomie (App) mit 25 Jahren, komplikationslos
Rechte Metacarpalknochen Fraktur, konservativ behandelt (Mittelhandknochenfraktur)

- **Allergien/ Unverträglichkeiten:**

Pollenallergie in der Kindheit, (Rhinokonjunktivitis)

- **Genussmittel/ Drogen:**

- Nikotinkonsum: 10 Zigaretten/Tag seit 3 Jahren
- Alkoholkonsum: 3–4 Gläser Weißwein abends
- Drogenkonsum: wurde verneint.

- **Sozialanamnese:**
  Polizist
  geschieden
  Ein Sohn

- **Familienanamnese:**
  Vater: Herzrhythmusstörung (HRST), trägt einen Herzschrittmacher
  Mutter, 78 Jahre: Depression, Gastritis
  Bruder (Zwilling): Z.n. MI vor 1,5 Jahren

- **Verdachtsdiagnose:**
  GERD (Gastroösophageale Refluxkrankheit)

- **Differentialdiagnose**
  Ulcus ventriculi
  Akute Gastritis
  Magenkarzinom
  ACS

- **weitere Diagnostik**
- KU
- EKG
- Labor: BB - CRP - BSG - BZ - Leberwerte - Nierenwerte - Elektrolyte - Herzmuskelenzyme (Trop, CK-MB)
- FOBT (Fäkaler okkulter Bluttest)
- Sono Abdomen
- ÖGD + Biopsie
- Gastroenterologisches Konsil
- Langzeit-PH-Metrie

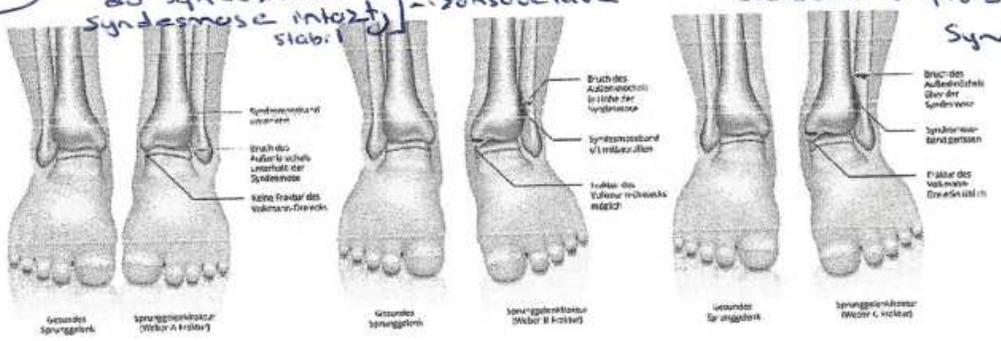
- **Therapievorschläge**
- ambulante Therapie
- Patientenschulung
- Lebensstilveränderung (magenschonende Ernährung /Sport/enge Kleidung vermeiden)
- Alkoholkarenz
- PPI
- Ggf. H.pylori-Eradikation
- Ggf. Fundoplikatio nach Nissen

Weber Einteilung der OSG-Fraktur (Oberes Sprunggelenk)

Weber A → Fraktur unterhalb der Syndesmose, Syndesmose intakt, stabil → konservative

Weber B → Fraktur auf Höhe Syndesmose, Syndesmose eventuell verletzt → teils instabil → operative

Weber C → Fraktur oberhalb Syndesmose, Syndesmose ruptiert (1) → instabil → operative



4. GERD s.32

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

Notizen: Notaufnahme, deutlich, spricht schnell und umgangssprachlich

- Rita / Reneta Cordes / Anita Nordhaus
- 67 J.
- *02.02.1955
- 1,68 m
- 74,6/ 87,5 kg
- ~~Ich bin hier seit 2 Stunden und habe lange gewartet~~ → Das tut mir Leid. Aber Sie sind in der Notaufnahme und leider hatten wir eine akute Notfall und diese musste zuerst behandelt werden, aber jetzt können wir starten.
  - Ich danke Ihnen, dass Sie so lange gewartet haben. Wir sind in der Notaufnahme, es gibt viele Patienten. Aber ich bin jetzt für Sie da und kümmere mich um Ihre Beschwerden.

-Hauptbeschwerde

- Brustschmerzen/Oberbauchschmerzen
  - Gestern Abend: ich hatte gestern Abend einen sehr starken Schmerz in der Brust
  - 1 Stunde angedauert: wie Attacke
  - Plötzlich
  - Postprandial (kurz nach dem Essen von Bratkartoffeln und Bratwurst)
    - ~~Ich komme aus Düsseldorf, hier trinken wir Altbier, haben Sie das probiert? Mit Bratwurst und Bratkartoffeln~~ → Nein, ich habe noch nicht ordnet. Aber ich habe gehört, dass es sehr gut schmeckt.
      - Ja ich habe es schon probiert und es schmeckt sehr gut
  - Retrosternal
  - Ausstrahlung in den Hals
  - brennend/ wellenförmig
  - 5-6/10
  - Seit heute Morgen nicht mehr
- Ähnliche Beschwerden seit 6 Wo.: intermittierend → auch 1 Stunde
  - besonders nachts
  - 3-4 Mal/Wo.
  - 1 Stunde
  - Progressiv: es wird mit der Zeit immer schlimmer
  - Oberkörperhochlagerung (2 Kissen): ich muss fast im Sitzen schlafen
    - Wie viele Kisse benutzen Sie nachts?
- Sodbrennen (Pyrosis)
  - Seit 6 Wo.
- Saurer Geschmack im Mund/ saures Aufstoßen: Ich rülpse immer (rülpsen: Aufstoßen)
  - Seit 6 Wo.
- Nausea +
- Emesis –

(2)

- Heute wollte ich zu meinem Hausarzt gehen, aber er war im Urlaub, ist es ok, dass ich hierhergekommen bin?
  - Die Notaufnahme ist keine Hausarztpraxis. Aber jetzt, da Sie hier sind und wir begonnen haben, werde ich mich um Sie kümmern

Es ist okay, weil Ihr Hausarzt im Urlaub ist. Sie habe gute Entscheidung getroffen, hierher zusammen. Ich kümmere mich um Sie

- Haben Sie Atemnot?
- Haben Sie sich am Brustkorb verletzt?
- Haben Sie Verdauungsprobleme?
- Haben Sie Schluckbeschwerden?
- Haben Sie Heiserkeit?
- Haben Sie Husten?
- Haben Sie B-Symptome?
- Gibt es eine bestimmte Körperlage, bei der sich die Schmerzen verbessern/verschlechtern? Wie: Rückenlage, Bücken, Pressen, körperliche Anstrengung?

-vegetative Symptomatik

- Dyssomnie +: Ich muss nachts 2 Kissen benutzen

-gyn

- Menopause seit 12 J/als ich 50 LJ war
- Menarche mit 13. LJ/11. LJ
- Vor 6 Mo. beim Frauenarzt

-Vorerkrankungen

- aHT seit 15 J. letztes Mal heute Morgen 130/80 mmHg
  - Das ist eine gute Messung. Ich freue mich, dass Ihr Blutdruck gut kontrolliert ist.

-Vor-OPs

- Vor 30 J. Plattenosteosynthese: Sprunggelenkfraktur rechts vor 30J. (konservativ behandelt)
  - Ich bin mit dem Fuß umgeknickt. Ich habe Gips/Schiene getragen, bin ich mir nicht sicher ob es OP ist
    - Haben Sie dafür in einem Operationssaal ein Betäubungsmittel erhalten? Anästhesiehaube
    - Dann handelt es sich nicht um eine Operation.

-Medikation

- Amlodipin 10 mg Tbl. 1-0-0
- Ramipril 5mg Tbl. 1-0-0
- Könnten die Beschwerden eine Nebenwirkung meiner Medikamente sein?
  - Ja das ist auf jeden Fall möglich aber wir werden das überprüfen.

-Allergien

- Pollenallergie/Heuschnupfen (Rhinitis) als Kind (Sternutio, Rhinokonjunktivitis) Heuschnupfen
  - Wenn im Frühling Pollen fliegen, muss ich niesen und habe rote Augen

-Noxen

- Tabak: Ex-Raucherin seit 27 J. / vorher 10 Zig./T 10 (15) Jahre lang
  - Ich habe mit meiner Schwangerschaft aufgehört. Ich habe zwischen meinem 30. und 40. Geburtstag geraucht.
  - Es ist wirklich toll, dass Sie mit dem Rauchen aufgehört haben, bravo!
- C2: 2 Gl. Altbier/Bier/d nach dem Abendessen
  - Aus medizinischer Sicht sind zwei Bier pro Tag etwas zu viel. Vielleicht könnten Sie versuchen, nur am Wochenende zu trinken?
- Drogen:-

-Sozialanamnese

- Rentnerin seit 5 Mo. Vorher Zugbegleiterin/ Kundeberaterin
- Verheiratet, Wohnt zusammen mit ihrem Mann
  - ~~Er ist auch ein Zugbegleiter und wir haben uns da kennengelernt.~~ Ah so schönes Treffen!
- 1 Tochter (gesund)
- 2 Enkel

-Familienanamnese

- Vater (88J.): t an Ösophaguskarzinom vor einem Jahr
  - ~~Habe ich auch Krebs wie mein Vater?~~
  - Ich glaube nicht, aber wir werden einige Untersuchungen durchführen, um sicher zu sein.
- Mutter (88J.): Apoplex (vor einem Jahr, 76), DM Typ 2, aHT unkontrolliert, im Altenheim
- Schwester: Depression (Schwermütigkeit)

Bei einem Tumor sind die Befunde ganz anders.

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.
Ich habe einen Verdacht **auf Refluxkrankheit**. Das bedeutet, dass die Säure aus Ihrem Magen in Ihre Speiseröhre aufsteigt. Das ist nicht schlimm und kann einfach mit Säureblockern behandelt werden. Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.
Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, dann werde ich Ihnen etwas Blut abnehmen. Und danach werden wir ein EKG und ggf. eine Magenspiegelung durchführen. Wissen Sie, was das ist?

EKG:
Ein EKG ist eine schmerzfreie und Strahlenfreie Untersuchung. Es dauert nur 5 Minuten und wir legen Elektroden auf Ihre Brust und Ihre Gliedmaßen, um den Rhythmus Ihres Herzens zu registrieren. Sie müssen nur ruhig liegen bleiben.

Magenspiegelung / ÖGD:
Die Magenspiegelung ist eine Untersuchung, mit der wir die hohlen Organe in Ihrem Körper beobachten können. Dazu führen wir einen Schlauch mit einer Kamera durch den Mund ein. Wir geben Ihnen ein Beruhigungsmittel, damit Sie nichts spüren. Wir können auch einige Gewebeproben (Biopsien) entnehmen, damit können wir eine Diagnose stellen.

Da können wir den Magen von Innen direkt beurteilen.

Haben Sie noch Fragen?

-Fragen

Was habe ich? Soll ich hierbleiben? Ja im Moment sollen Sie im Krankenhaus bleiben. Wenn wir die Untersuchungen abgeschlossen haben, werde ich Ihnen sagen, ob Sie bleiben sollen oder nach Hause gehen können.
Muss ich operiert werden? Moment, glaube ich nicht aber wir werden weitere Untersuchungen durchführen, um sicher zu sein.
Was machen Sie für mich? Was ist EKG? Was ist ÖGD? Das ist unangenehm, warum müssen Sie diese Untersuchung machen? Was sind die Komplikationen von ÖGD? Es gibt jedoch einige Risiken, die selten auftreten, wie z.B. eine Infektion oder das Risiko von Blutungen aufgrund einer Wandverletzung.
Welche Laboruntersuchungen? Können Sie im Labor verstehen, ob ich Krebs habe? Wir werden die Entzündungsparameter, die Nierenwerte, die Herzmuskelenzyme, um eine Herzursache auszuschließen, sowie die Tumormarker (CEA, CA19-9) überprüfen. Ja genau, einige Tumore, darunter auch Magenkrebs, sondern Eiweiße ab, die man im Blut bestimmen kann.
Haben Sie genug Betten? Ja kein Problem
Machen Sie selbst die Magenspiegelung? Nein, ich rufe dafür einen Kollegen von der Gastroenterologie an. Sie sind Spezialisten und haben viel Erfahrung.

Im Blut kann man Krebs nicht sicher erkennen. Dafür braucht man weitere Untersuchungen

absondern -> Schleimhaut, diese verletzt

✓ **Was ist eine Ultraschalluntersuchung?** Als ich jung war, war die Untersuchung nicht gut, die Ärzte haben mir gesagt, dass ich einen Sohn habe, aber dann hatte ich eine Tochter.

- Ja der Ultraschall ist nicht 100% sicher bei Schwangerschaft. Es hängt vom Alter des Fötus und dem Auge des Untersuchers ab. Aber machen Sie sich keine Sorgen, unsere Ärzte haben viel Erfahrung und wir werden klären, was in Ihrem Magen vor sich geht.

(4)

Arzt-Arzt-Gespräch

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Notaufnahme.

Es geht um **Frau Anita Nordhaus, 67** Jahre alt, die in gutem AZ (Allgemeinzustand) und adipösem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Sie beschreibt Ihre aktuellen Symptome wie folgt: seit gestern Abend brennende kolikartige epigastrische und retrosternale Brustschmerzen. Sie haben plötzlich post-Prandial begonnen nach dem Verzehr von Bratwurst und Bratkartoffeln (fettiges Essen). Sie haben eine Stunde lang angedauert und dann ~~weg waren~~ (intermittierend/rezidivierende). 5-6 von 10 auf einer Schmerzskala.

Ähnliche Beschwerden seit 6 Wo., besonders nachts, 3-4 Mal pro Woche.

Begleitend ist seit 6 W. Nausea und Sodbrennen (~~Pyrosis~~) mit saurem Aufstoßen (Ructus).

Sie hat keine Fieber und keine Dyspnoe. Aber sie hat wegen dieser retrosternale Schmerzen Dyssomnie und soll ihren Oberkörper zum Schlafen erhöhen. **Ansonsten ist die weitere vegetative Anamnese unauffällig.**

Sie leidet seit 15J. an aHT und nimmt regelmäßig dagegen Amlodipin 10mg und Ramipril 5mg.

Die Patientin hat früher 5 p.y. (10 Zig. pro Tag während 10J.) geraucht.

In der Familienanamnese gibt es einem Ösophaguskarzinom.

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf GERD *(gastroesophageal reflux disease)*. An Differentialdiagnosen sind zu nennen Akute Gastritis, Ulcus ventriculi, Hiatalhernie oder ACS.

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen; dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: gr. BB, CRP, ~~BSG, ggf. PC~~T, Amylase, Lipase, Leber-Nierenwerte, E-lyte, Herzenzyme (Trop.I, T, CKMB), Glukose, ~~Tumormarker (CEA, CA 72-4)~~ und ~~eine Stuhluntersuchung + FOBT (Fäkaler okkulter Bluttest).~~

Dann, ein Ruhe-EKG ist durchgeführt werden, um eine kardiale Ursache zu vermeiden. Ggf. wäre eine ÖGD angezeigt und ist ein Gastroenterologische Konsil anzufordern. Ggf. eine langzeit-pH-metrie und eine Abdominale-Sonographie.

Als Therapie schlage ich <u>initial/symptomatisch</u> Lebensstilveränderung (Diät mit Magenschonende Ernährung, Sport, Alkoholkarenz) und Protonpumpeninhibitor (PPI) vor. Ggf. H2-Rezeptor-Antagonisten (Cimetidin, Ranitidine), Antiazida (Magnesiumhydroxid), Alginat, Sucralfat.
Bei <u>kausal</u> empfehle ich ggf. H.Pylori-Eradikation; ggf. laparoskopische Fundoplicatio.

Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

-fragen

Es zeigt das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße, dient zur Beurteilung ob jemand unter, normal oder übergewicht ist. BMI wird berechnet, indem man das Gewicht im kg durch die Körpergröße im Meter zum Quadrat teilt.

Warum Größe und Gewicht? BMI-formel (der Quotient aus Körpergewicht und Größe)
Ist sie übergewichtig? BMI = 26 / 31 ☐ Ja sie ist übergewicht
Was isst die Pat. gerne? Fetthaltiges Essen

Auslöser der Schmerzen? Bei Hinlegen

Trinkt sie nur Altbier? oder schwindelt sie? Was bedeutet schwindeln? eine Störung des Gleichgewichtssinns / oder sie fabuliert / lügt

Was sind Bratkartoffeln? In Scheiben geschnittene Kartoffeln, die in Butter goldbraun gebraten werden. Sie werden gesalzen und gepfeffert. / Kartoffeln in der Butter gekocht

Was ist Mettbrötchen? Mettbrötchen ist eine Spezialität mit rohem Schweinefleisch auf Brot, mit rohen Zwiebeln.

Was ist Brötchen? Einzelnes Brot

Was ist Makrelen-Röllchen? Fingerfood aus Vietnam

- ❑ Amlodipin ❑ Calciumkanalblocker (Hypertonie)
- ❑ Ramipril ❑ ACE-Hemmer (Hypertonie)

Arten von Depression:

- Major Depression
- Psychotische Depression
- Prä- und postnatale Depression
- Bipolare Depression
- Zyklothyme Störung
- Dysthymie
- Jahreszeitlich bedingte affektive Störung (Herbstwinter-Depression)

Was ist Apoplex? Typen? Pathophysiologie? Therapie?
= die plötzliche Durchblutungsstörung des Gehirns (= Hirnschlag) mit fokalen neurologischen Defiziten

- Der **Ischämische Schlaganfall** (= Hirninfarkt)
  - Ursache: **Gefäßverschluss** durch Ablagerungen (Cholesterin) / Blutgerinnsel (Thrombus)
  - Unterversorgung der jeweiligen Hirnregion mit Sauerstoff und Nährstoffen ❑ Nervenzellen sterben ab
  - Therapie: Rekanalisation (= Wiederöffnung des Gefäßes)
    - Medikamentöse Thrombektomie = **Thrombolyse** (Achtung vor dem Zeitfenster: etwa 4 – 4,5 Stunden ab Symptombeginn) mit Alteplase (rt-PA = *recombinant tissue plasminogen activator*)
    - Operative **Thrombektomie** (Katheterintervention)
- Der **hämorrhagische Schlaganfall** (= Hirnblutung)
  - 2 Subtypen: Intrazerebrale Blutung (=ICB) / Subarachnoidalblutung
  - Ursachen: Hypertonie, Atherosklerose (Gefäße reißen leichter), Aneurysmenruptur (= Gefäßaussackung)
  - Unterversorgung der jeweiligen Hirnregion mit Sauerstoff und Nährstoffen ❑ Nervenzellen sterben ab
  - Therapie: OP (Hemikraniektomie, um Ödeme zu lindern)
- Die **TIA** = transitorische ischämische Attacke
  - wenn sich die Symptomatik < 24h wieder zurückbildet

Symptome:

- Lähmungen (halbseitige Lähmung = Hemiparese)
- Sprach-, Seh-, und Gleichgewichtsstörungen (Aphasie, Hemianopsie)
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Übelkeit und Erbrechen
- Bewusstseinstrübung, Amnesie

Aufnahme: < 3 Stunden für die beste Wirkung

- Intensivmedizinische Überwachung: Blutdruck, Herzfrequenz, Atmung, Zuckerwerte, Körpertemperatur, Nierenfunktion, Hirnfunktion, E-lyte und Wassergleichgewicht, Säuren-Basen-Haushalt

Was macht eine Zugleiterin? Sie empfängt die Passagiere des Zugs und kontrolliert die Tickets
Was ist GERD? Gastroesophageal reflux disease = Refluxkrankheit
Risikofaktoren der Pat. für GERD?
- Fetthaltiges Essen
- Nikotin-/Alkoholkonsum
- Übergewichtig
- Familiäre Vorbelastung
- Kalziumkanalblocker

Komplikationen von GERD? MUSE
- Ulzeration, Stenosierung, Striktur, Kachexie, Anämie, Blutung, Barrett → Karzinom

Leberwerte hoch/ HB: 11.9/ MCV: 79 (mikrozytäre Anämie) → FOBT (Fecal Occult Blood Test) / Ursache?
Erosive GERD, Magenkarzinom, Kolon-CA

Therapie? Therapie der Wahl: PPI (unterdrücken die Säureproduktion)
Falls PPI nicht klappt → ÖGD, um eine andere Ursache zu bestätigen (H.Pylori, perniziöse Anämie). Wenn o.p.B. → OP (Fundoplikatio nach Nissen)

Welche PPI kennen Sie? Omeprazol, Esomeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol

Lebensstilveränderung:
- Gewichtsreduktion
- Keine Mahlzeiten am späten Abend / kein sofortiges Hinlegen nach dem Essen
- Leichte Oberkörperhochlagerung während der Bettruhe
- Nikotinkarenz und Reduktion des Alkoholkonsums

Barrett-Ösophagus: intestinale Metaplasie, Umwandlung des Plattenepithels in ein Zylinderepithel. Potenziell Präkanzerose/ im Rahmen eines chronischen Refluxes von saurem Mageninhalt/ engmaschige endoskopische Kontrolle

Warum PPI in Pankreatitis? In der akuten Phase einer Pankreatitis kann eine erhöhte Säureproduktion in Magen / Duodenum führen. PPI helfen, solche Komplikationen zu vermeiden.

CK-Typen: BB, MB, MM
Welche Laborwerte werden durch Adipositas erhöht? LDL-Cholesterin, Triglycerid

Wie heißt es, wenn die Schmerzen sich durch Liegen verschlechtern?

Pathologie von pAVK?
- Die chronische pAVK
  - ca. 95 % d.F. eine Manifestationsform der Arteriosklerose.
  - Vaskulitis (z.B. Thrombangiitis obliterans, Riesenzellarteriitis, Takayasu-Arteriitis)
  - zystische Adventitiadegeneration
  - traumatische Gefäßverletzungen
  - fibromuskuläre Dysplasie
- Eine akute Extremitätenischämie
  - in 20 % d.F. aufgrund einer arteriellen Thrombose (z.B. i.R. einer pAVK).
  - Häufiger durch eine Embolie z.B. bedingt durch ein Popliteaaneurysma oder durch kardiale Thromben bei Vorhofflimmern

Was ist Hiatushernie? Zwerchfellbruch/ ist eine Verlagerung von Magen(-anteilen) aus der Bauch- in die Brusthöhle.

Was sind die Tumormarker?

- CEA = karcinoembryonäre Antigen
- CA 72-4: Cancer-Antigen zum Verlaufskontroll von Magenkarzinom

5. Hyperthyreose s.39

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

- Maja Wüller
- 46 J.
- *01.01.1977
- 1,67 m
- 77,3 kg

-Hauptbeschwerde

- Tachykardie: Herzrasen
  - Seit heute Morgen
  - Attackartig
  - Jede Attacke 15 min
- Vertigo (Schwindel): mir ist schwindelig und ich habe Angst vor Umkippen
  - Gleichzeitig mit Herzrasen
  - Keine Auslöser
  - Seit 2 W.
  - 4 Attacken
  - 1-2 Min
  - Baldrian: keine Besserung)
- Synkope / Kollabieren: Ich bin umgekippt 2 Mal
  - Die erste vor 2 W. während der ersten Schwindelattacke, beim Frühstück mit meiner Freundin, 2 Minuten.
  - Die zweite vor 10 T.
  - Gebissene Zunge -
  - Ungewollte Miktion (Einnässen) +: ich habe mich eingenässt
- Diarrhö: Durchfall / Dünner Stuhl
  - Seit 2 W.
  - Wässrig
  - 1-2 M/d
  - Kein Blut
- Begleitend:
  - Globus Kloßgefühl + (wie ein Frosch im Hals)
  - Zitternde Hände / Kribbeln + in den Händen + (während und gleich nach der Attacke)
  - Wärmeintoleranz + (ich muss immer das Fenster aufreißen)
  - Nervosität +
  - Tinnitus + (während und gleich nach der Attacke)
  - Parese -
  - Nackensteifigkeit -
- Wegen der Symptome letzte Woche im KH o.p.B, Warum bin ich entlassen worden?
  - Ich kann Ihnen leider nicht antworten, aber Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, hierher wiederzukommen. Wir werden uns um Sie kümmern und Ihnen die richtige Behandlung für Ihre Beschwerden geben.

Patient/in

Mathias Böser
52 J. 06.01.1971
1,92 m. 90 kg

GERD

Hauptbeschwerden:

Leitsymptome

- Brustschmerzen, retrosternal → retrosternale Schmerzen
- gestern Abend, nach dem Essen (Bratkartoffel) plötzlich aufgetreten
- mit Ausstrahlung in den Hals
- brennend, ziehend
- rezidivierend seit 3 Wochen, leichter
- Vorsorgende Faktoren: Hinlegen
- lindernde Faktoren: Maalox, Gaviscon (Abstand der Einnahme von mit 2 Kopfkissen liegen oder Oberkörperhochlagerung beim Schlafen)

Begleitsymptome

- Sodbrennen (Pyrosis)
- saures Aufstoßen (Ructus)
- Übelkeit (Nausea)
- saurer Geschmack im Mund (Dysgeusie)

Vegetativanamnese

- Inappetenz

Vorerkrankungen

- aHT seit 5 Jahren (kontrolliert, letzte Messung: 120/80)
- Hypercholesterinämie seit 3 Jahren
- Gastritis

OP

- Appendektomie mit 25 Lj.

Medikamentenanamnese

- Candesartan 16 mg (1-0-0)
- Simvastatin 20 mg (0-0-1)
- Maalox b.B
- Gaviscon b.B

Kennen Sie Dosierung?

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

Allergien / Unverträglichkeiten

unauffällig

Genussmittel

Nikotin: ~~20~~ 4 py (10 Zigaretten täglich ~~[illegible]~~ 5 Jahre long)

Alkohol: 2 Gläser Wein jeden Abend

Drogen: unauffällig

Sozialanamnese

- Polizisten
- Stress bei der Arbeit
- geschieden
- einen Sohn
- wohnt allein

Familienanamnese

Mutter: Adipositas, Depression, Gastritis

Vater: aHT, Apoplex, Herzschrittmacher seit 2 Jahren, im Rollstuhl

Bruder: 2.n. MI vor 6 Monaten

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

(benutzen Sie Fachwörter, wo möglich) Verdachtsdiagnose

GERD

Differentialdiagnose

- Gastritis
- ACS

weiteres Procedere

- KU
- Vital Parameter, EKG
- Labor: gr. BB, Entzündungsparameter (CRP), Herzenzymbelenzyme (Troponin T, I, CKMB)
  Lip. dprofil, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte,
- ggf. 24 Stunde pH-Metrie
- ggf. ÖGD → wichtig, daher sowie 24-Stunde pH-Metrie →

) Diagnosis ex juvantibus (Eine Diagnose, die anhand der ~~Therapie~~ Wirkung einer Therapie gestellt wird)

Therapie

- ambulante Behandlung
- Analgetika
- Antiemetika
- PPI - Protonen Pumpen Hemmer
- Patientschulungen
- Alkoholkarenz
- Lebensstilveränderungen (Diät, magenschonende Ernährung, enge Kleidung vermeiden)
- ggf. gastroenterologisches Konsil

✓ 3c Verdacht auf GERD erfolgt zunächst eine ÖGD zum Ausschluss von Komplikationen. Eine 24 Stunden-pH-Metrie wird durchgeführt, wenn die Endoskopie unauffällig ist oder vor einer operativen Therapie

Zu den wichtigsten Tumormarkern gehören

CA 19-9
CEA } Magen, Pancreas, Gallenwege

CEA → Kolonkarzinom

AFP → Leberkarzinom (HCC)

CA 125 → Eierstockkarzinom
HE4

CA 15-3
CEA } Brustkarzinom
HER2

PSA → Prostatakarzinom

AFP
β-HCG } Hodenkarzinom
LDH

NSE
pro GRP } Lungen
CEA

Thyreoglobulin } Schilddrüsenkarzinom
Calcitonin

LDH
β2 Mikroglobulin } Hämatologische Maligne

Sie dienen vor allem zur Verlaufs und Therapiekontrolle nicht zur Erstdiagnose.

Maaloxon ist ein Antazidum und neutralisiert die Magensäure. Maaloxen enthält Aluminiumhydroxid Magnesiumhydroxid

Gaviscon enthält Alginate und bildet eine Schutzschicht auf dem Mageninhalt, die den Reflux verhindert.

Maaloxon und Gaviscon können zusammen angewendet werden, sollten aber zeitlich versetzt eingenommen werden.
nach dem essen
vor Schlafgehen
bei Reflux

MCV – mittleres korpuskuläres Volumen

Bei chronischem Alkoholkonsum steigt das MCV aufgrund von Folsäuremangel, direkter Knochenmarktoxizität und Lebererkrankungen.

FOBT → fäkaler Occult Blut Test

Ein Abszess ist eine umschriebene Eiteransammlung im Gewebe

Ein Empyem ist eine Eiteransammlung in einer Körperhöhle z.B im Pleuraspalt.

Die Palliativmedizin kann in Deutschland als eigenständige zusätzliche Qualifikation erworben werden und behandelt umfassend die Lebensqualität von unheilbar Kranken

* pH-Metrie

Bei der pH-Metrie ~~wird~~ messen wir über 24 Stunden, wie oft und wie stark Magensäure in die Speiseröhre zurückfließt. Dafür wird eine dünne Sonde durch die Nase in die Speiseröhre gelegt. Das tut in der Regel nicht weh und Sie können ganz normal essen und sich bewegen

H.pylori Behandlung

Die aktuelle standardtherapie zur H.pylori-Eradikation ist eine 10-14 tägige Vierfachtherapie mit PPI, Bismut, Tetracyclin, und Metronidazol

Urease Test

Beim Urease-Atemtest trinken Sie eine spezielle Flüssigkeit und pusten danach in ein Röhrchen.
(Öhlmiz)

Beim Stuhltest geben Sie eine kleine Stuhlprobe ab.
Beide Tests zeigen, ob aktuelle ~~Helicobacter~~ H.pylori vorhanden ist.

Der Urease-Atemtest und der Stuhlantigentest dienen dem Nachweis einer aktiven H.pylori Infektion.

Trombositopenie

Trombosit transfusionen sind Isoactical human gusselums oyuda sunbl ehus gurdu.

Unter trombosit gerekte +20.000 - 40000 / µl altıs sayıları (cuda b hasta

Trombosit yarı ömrü 3-5 gündür. O yüzden 3-5 gün yetiş salı. ama azalı sonra, sepsis, DIC, inme yok varsa transfusiyon

zwei Thrombozytenkonzentrate werden zur Erreichung von 50.000 (µl benötigt.

Diagnosis ex juvantibus → Eine Diagnose, die anhand der Wirkung der Therapie gestellt wird.

Der Patient nimmt zwei Woche lang PPI. ~~Dann~~ ~~wurde~~ Wenn die Beschwerden reduziert werden, wird die Krankheit bestimmt.